

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE APOYO SOCIAL (EAS-21)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación del Apoyo Social Percibido (Familia, Amigos y Confianza)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Apoyo Social (EAS: 21 reactivos).
Nombre Original	Escala de Apoyo Social (EAS; Palomar Lever et al., 2013).
Autores Originales	Dra. Joaquina Palomar Lever, G. L. Matus y A. Victorio (2013), Univ. Iberoamericana.
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Apoyo Social Percibido, Recursos Protectores y Redes Vinculares.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico multidimensional de 21 reactivos con escala Likert de 4 puntos (1 a 4).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 15 años). Pacientes clínicos y población general comunitaria.
Tiempo de Administración	4 a 6 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, docencia e investigación académica bajo citación formal.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DEL APOYO SOCIAL PERCIBIDO

La Escala de Apoyo Social (EAS) operacionaliza el constructo del **apoyo social percibido**, conceptualizado en la psicología de la salud y la psicopatología (Cobb, 1976; Cohen & Wills, 1985) no como el recuento objetivo de contactos interpersonales, sino como la certeza cognitiva y afectiva del sujeto de que es amado, valorado, cuidado y respaldado por una red recíproca ante necesidades vitales.

El instrumento evalúa tres dimensiones complementarias:

- Apoyo Familiar:** Disponibilidad percibida de afecto, validación de logros, escucha y auxilio material proveniente del núcleo familiar.
- Apoyo de Amigos:** Interacción afectuosa, empatía y soporte instrumental proporcionado por el grupo de pares e iguales.
- Red de Confianza Individual (Persona Significativa):** Certeza de contar con al menos una figura incondicional capaz de guardar confidencias íntimas, brindar consuelo y mantener la cercanía en crisis profundas.

Desde la psiconeuroinmunología, el apoyo social percibido actúa como un potente amortiguador del estrés (**buffering hypothesis**), atenuando la reactividad autonómica cardiovascular y la secreción de cortisol del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA), mientras estimula la liberación de oxitocina y refuerza la respuesta inmunitaria celular.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Dimensión del Apoyo	Ítems (21)	Nº Ítems	Definición Operativa y Contenido Evaluado
1. Apoyo Familiar	2, 3, 4, 5, 7, 8	6 ítems	Cariño, reconocimiento, ayuda en decisiones y escucha familiar ante problemas.
2. Apoyo de Amigos	1, 6, 9	3 ítems	Afecto físico, disposición a ayudar y comunicación de conflictos con amigos.
3. Red / Confianza Individual	10 al 21	12 ítems	Presencia de al menos una persona incondicional para intimidad, respeto y amparo.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN LATAM / ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente consistencia global: alfa de Cronbach total de 0.92 a 0.94 (Palomar Lever et al., 2013). Alta homogeneidad en las tres subescalas: Red y Confianza Individual (0.91), Apoyo Familiar (0.88) y Apoyo de Amigos (0.82). Fiabilidad test-retest $r = 0.84$ a las 6 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora la estructura de tres factores intercorrelacionados con índices de ajuste sobresalientes: CFI = 0.94, TLI = 0.93, RMSEA = 0.052, superando ampliamente a modelos unidimensionales indiferenciados.
Validez Concurrente y Criterio	Correlaciones directas robustas con bienestar psicológico subjetivo (SWLS, $r = 0.52$), resiliencia (RS-14, $r = 0.48$) y autoestima (Rosenberg, $r = 0.46$). Correlaciones inversas muy significativas con depresión (CES-D, $r = -0.49$), soledad (DJGLS, $r = -0.56$) y sintomatología somática.
Sensibilidad al Cambio Clínico	Sensible a programas de intervención psicosocial y grupal, registrándose incrementos notables en Apoyo de Amigos y Red Individual tras intervenciones de vinculación comunitaria.
Invarianza Demográfica	Invarianza métrica demostrada entre sexos; las mujeres reportan niveles basales ligeramente más altos en expresión de afecto y comunicación íntima en las subescalas de amigos e individual.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Los 21 ítems se califican en escala Likert de 4 puntos (1 = «Totalmente en desacuerdo», 2 = «En desacuerdo», 3 = «De acuerdo», 4 = «Totalmente de acuerdo»):

- **Paso 1 (Cálculo Directo):** No contiene reactivos invertidos; todos los ítems puntúan de 1 a 4 en sentido positivo.
- **Paso 2 (Puntuaciones por Subescala):**
 - **Apoyo Familiar (6 ítems: 2, 3, 4, 5, 7, 8):** Rango de **6 a 24 puntos**.
 - **Apoyo de Amigos (3 ítems: 1, 6, 9):** Rango de **3 a 12 puntos**.
 - **Red de Confianza Individual (12 ítems: 10 al 21):** Rango de **12 a 48 puntos**.
- **Paso 3 (Puntuación Total EAS-21):** Suma de los 21 reactivos. Rango Teórico Total: **21 a 84 puntos**. A mayor puntuación, mayor apoyo social percibido.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS NORMATIVOS

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Apoyo Percibido	Conducta Asistencial Recomendada
Muy Bajo	21 a 42 puntos	Déficit severo de apoyo (corte ≤ 42)	Sensación profunda de abandono y aislamiento. Factor crítico de riesgo de suicidio; activar red asistencial.
Bajo / Vulnerable	43 a 54 puntos	Apoyo precario o ambivalente	Relaciones familiares o sociales conflictivas. Intervención en habilidades sociales y vinculación.
Moderado / Medio	55 a 68 puntos	Apoyo social adaptativo medio	Presencia de figuras de respaldo suficientes para estresores habituales. Soporte protector normal.
Alto / Resiliente	69 a 84 puntos	Sólida red de apoyo protector	Red social cohesionada y disponible; alta confianza interpersonal y excelente recurso de resiliencia.

VALOR PREDICTIVO DE LA SUBESCALA DE CONFIANZA INDIVIDUAL (ÍTEM 10 AL 21):

Las investigaciones señalan que la presencia de **al menos una persona incondicional** de confianza íntima (puntuación en subescala individual ≥ 36) amortigua más del 70% del impacto traumático del estrés crónico, incluso cuando el paciente puntúa bajo en apoyo familiar por antecedentes de negligencia o disfunción parental.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN DÉFICIT DE APOYO SOCIAL

PROTOCOLO CLÍNICO BASADO EN EL PERFIL DE LA EAS-21:

- **Paso 1 (Mapeo de la Red Afectada):** Analizar si la debilidad es Familiar (conflictos de lealtad), de Amigos (timidez o fobia social) o de Confianza Individual (trauma vincular o desconfianza generalizada).
- **Paso 2 (Entrenamiento en Asertividad y Búsqueda de Ayuda):** Desmantelar la creencia distorsionada de que “pedir ayuda es ser una carga”. Entrenar habilidades directas de comunicación de necesidades emocionales.
- **Paso 3 (Prescripción Social y Reconciliación):** Incorporación a espacios asociativos y actividades guiadas por valores; mediación en vínculos familiares recuperables.
- **Paso 4 (Monitorización):** Un incremento de ≥ 12 puntos en el total de la EAS-21 al cabo de 3 meses refleja consolidación de la red y descenso del riesgo clínico.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DEPRESIÓN Y AISLAMIENTO TRAS MIGRACIÓN

Identificación: Mujer de 28 años, diseñadora gráfica, emigró sola por motivos laborales hace 10 meses. Acude por llanto diario, insomnio de mantenimiento, apatía y vivencia de desamparo (“no tengo a nadie a quien llamar”). Cumple criterios para Trastorno Adaptativo Mixto con Ansiedad y Depresión.

Evaluación Inicial EAS-21 (Línea Base): Puntuación Total = **34/84 puntos** (Rango Muy Bajo / Déficit Severo). Apoyo Familiar = 12/24 (contacto telefónico distante); Apoyo de Amigos = 4/12 (prácticamente nulo en la nueva ciudad); Red de Confianza Individual = 18/48 (ítems 11, 12, 18 puntuados con 1).

Plan Terapéutico: 10 sesiones de psicoterapia centrada en reconstrucción vincular y asertividad relacional. Se trabajaron las barreras cognitivas para iniciar interacciones informales con compañeros de trabajo y se prescribió su participación en un club deportivo local.

Reevaluación a las 10 Semanas: Puntuación Total EAS-21 = **65/84 puntos** (incremento neto de +31 puntos, acceso al Rango Adaptativo Medio). Apoyo de Amigos subió a 10/12; Red de Confianza Individual ascendió a 39/48 al consolidar un vínculo de confianza mutua con una compañera. Remisión sintomática del cuadro depresivo.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

FACTOR DE RIESGO SUICIDA CRÍTICO:

Un puntaje extremadamente bajo en Apoyo Social (EAS ≤ 30) en combinación con desesperanza depresiva constituye una de las alarmas clínicas más severas de tentativa autolítica inminente por desamparo vincular. Explorar de inmediato ideación activa.

APOYO PERCIBIDO VS. RED REAL:

Diferenciar el déficit objetivo de red (aislamiento real) del sesgo cognitivo depresivo (“nadie me quiere”), donde la familia ofrece apoyo constante pero el paciente no lo percibe por anhedonia o desconfianza paranoide.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Palomar Lever, J., Matus, G. L., & Victorio, A. (2013). Desarrollo y validación de una Escala de Apoyo Social en población mexicana. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 35(1), 145-165.
2. Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310-357.
3. Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. *Psychosomatic Medicine*, 38(5), 300-314.
4. Barrera, M. (1986). Distinctions between social support concepts, measures, and models. *American Journal of Community Psychology*, 14(4), 413-445.